

ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

The effectiveness of a transitional care model for caregivers of stroke patients in a private hospital, Pathum Thani Province

จุฑามาศ สูดใจ* สุทธิพร มูลศาสตร์** และ วันเพ็ญ แก้วปาน***

Juthamas Sudjai, * Sutteeporn Moolsart, ** and Wonpen Kaewpan ***

*บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

** สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

*** ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

*Graduate Division, School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University

**School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University

***Public Health Nursing Department, Faculty of Public Health, Mahidol University

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 20 คน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านของเนลเลอร์ 2) คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ดูแล 3) แบบสอบถามความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.94 และ 1.00 และ 4) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลองมีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลองมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ดูแล, การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน, โรงพยาบาลเอกชน

*นักศึกษาลัทธิพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corresponding author E-mail: nana_chat@windowslive.com

วันที่รับบทความ: 11 ธันวาคม 2567 วันที่แก้ไขบทความ: 11 พฤศจิกายน 2568 วันที่ตอบรับบทความ: 19 พฤศจิกายน 2568

ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตชนบทเป็นวิถีชีวิตในเมือง การดำเนินชีวิตมีความเร่งรีบและเน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนลดลง

การศึกษาข้อมูลในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ไม่มาตรวจตามแพทย์นัด ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนที่ศึกษา ยังขาดทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง ขาดการติดตามหลังผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการถาวร ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นการดูแลผู้ป่วยตามระยะเปลี่ยนผ่านโดยเริ่มตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเมื่ออาการทุเลาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพต้องเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลกลับไปยังบ้านซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะผ่านพ้นไปได้โดยง่ายหรือมีความยากลำบากขึ้นอยู่กับระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านนั้น ๆ ของบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาตนให้สามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อีกสภาวะหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ (Sgueglia et al., 2022) ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความพร้อมในความรู้ ความสามารถ มีทักษะการดูแลผู้ป่วย และการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยเริ่มตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงจำหน่ายไปฟื้นฟูสภาพที่บ้านเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน

2. เปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน กลุ่มทดลอง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ดีวก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน

2. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน กลุ่มทดลอง ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ดีวกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านของ Naylor (2006) ที่เชื่อว่า การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านที่อยู่ในช่วงวิกฤต โดยให้ผู้ดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ความหมายและประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง พยาธิสภาพและผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2) การจัดสถานที่ในบ้านให้พร้อมต่อการดูแล 3) การเตรียมความพร้อมในการดูแล และ 4) การประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่

2. แบบสอบถามความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป จำนวน 14 ข้อ 2) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจและสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 ข้อ 3) ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย การดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และสังคม จำนวน 21 ข้อ และการจัดสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 ข้อ การตอบเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ ถูกต้อง ไม่แน่ใจ และไม่ถูกต้อง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน การแปลผลระดับให้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก และ 4.51-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด

3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แบบประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living [ADL]) ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายภายในห้อง การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ การใช้ห้องน้ำ การขึ้นลงบันได การสวมใส่เสื้อผ้า การกลืนปัสสาวะ การกลืนอุจจาระ การลุกนั่งบนเตียงนอนหรือจากเตียงไปที่เก้าอี้ การล้างหน้า หวีผม และโกนหนวด ในระยะเวลา

24-48 ชั่วโมง มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนรวม 3 ระดับ ได้แก่ 0-8 หมายถึง ภาวะพึ่งพารุนแรง 9-11 หมายถึง ภาวะพึ่งพานานกลาง และ 12-20 หมายถึง ไม่พึ่งพา

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล เท่ากัน คือ 0.94 และแบบสอบถามความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 1.00 และหาความเที่ยง (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปใช้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.72 และแบบสอบถามความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.95

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 24/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการวิจัย และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มตัวอย่าง สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยโดยไม่มีผลกระทบต่อการรับบริการทางสุขภาพ และให้ลงนามยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม ณ หอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ดังนี้

ระยะก่อนทดลอง วันแรกรับ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม ความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้ดูแลตอบ และประเมินความสามารถในการ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย

ระยะทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการตามโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลอง ดังนี้

ก่อนการจำหน่าย 1 วัน ฝึกทักษะเรื่องการรับประทานอาหาร การทำกิจกรรมทางกาย การจัดการกับความเครียด และการรับประทานยา ฝึกทักษะการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ฝึกทักษะการจัดการความเครียดและการคิดบวก วางแผนการดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่

หลังการจำหน่าย สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผ่านระบบวิดีโอคอล โดยระบุเป้าหมายและผลลัพธ์การดูแลร่วมกันกับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของแต่ละครอบครัวอย่างเหมาะสม **สัปดาห์ที่ 2** ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 3 คน ติดตามผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดที่แผนกผู้ป่วยนอกเพื่อประเมินความรู้และความสามารถของผู้ดูแลในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วย โดยดำเนินการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด เพื่อให้คำแนะนำและเสริมทักษะตามความจำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวซักถามข้อสงสัยที่พบระหว่างการดูแลที่บ้าน **สัปดาห์ที่ 3** ผู้วิจัยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางวิดีโอคอลโดยทำกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูด้านร่างกาย โดยให้ผู้ดูแลและผู้ป่วยฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำกิจกรรมตามใบงาน ติดตามประเมินปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย **สัปดาห์ที่ 4** ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ติดตามผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ครั้งที่ 1 ของผู้ป่วย พร้อมทั้งติดตามและ

แก้ไขปัญหาในการดูแล โดยทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากใบงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและตรวจสอบบันทึกสุขภาพที่ผู้ดูแลฉบับที่ไว้เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน **สัปดาห์ที่ 5** ผู้วิจัยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางวิดีโอคอล โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพผ่านกลุ่มไลน์ (LINE group) เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรมฟื้นฟูร่างกาย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การเดิน การออกกำลังกาย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัว

ระยะหลังทดลอง สัปดาห์ที่ 6 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ติดตามผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้ดูแลตอบอีกครั้ง และประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านครั้งนี้

กลุ่มเปรียบเทียบ คณะผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้ดูแลตอบ และประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2567 **สัปดาห์ที่ 1-5** ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลปทุมเวช **สัปดาห์ที่ 6** ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้ดูแลตอบ และประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพที่บ้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบที่